

Vaimse tervise strateegia 2016–2025 sõnastab valdkonna prioriteedid



Airi Mitendorf

*Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut*

Vaimse tervise strateegia 2016–2025 lähtub seisukohast, et vaimse tervise edendamine ning psüühika- ja käitumishäirete ennetamine, ravi ja taastumine tuleb seada prioriteetideks nii üksikisiku, kogukonna kui ka riigi tasandil.

Hea vaimse tervise puudumine ning psüühika- ja käitumishäired mõjutavad oluliselt iga nende all kannatavat inimest, tema perekonda ja kogu ühiskonda.

Näiteks on Eesti elanikkonnast 5,6% kogenud depressiooni. Maailma Terviseorganisatsioon on toonud välja, et depressioon on üks neljast enim levinud psüühikahäirest. Prognoositakse, et depressioonist saab 2030. aastaks kõige levinum haigus, hõlmates juba 15% elanikkonnast. Kõige äärmuslikum depressiooni avaldumise viis on suitsidaalsus (enesetapumõtted, -katsed ja enesetapud). 2015. a andmetel sooritas Eestis suitsiidi 196 inimest. Suitsiidisurma riskigruppideks on vanemaealised ja noored: 2015. aastal tegid 29% enesetappudest 65aastased ja vanemad inimesed, suitsiidi sooritas 22 noort (Statistika andmebaas 2016). Need numbrid kinnitavad, et Eestis peab elanike vaimne tervis paranema.

Strateegia koostamise taust

Strateegia koostamise vajadus tulenes sellest, et Eesti riigil pole vaimse tervise poliitikat, mis koondaks soovitusi, kuidas edendada vaimset tervist, vähendada diskrimineerivat häbimärgistamist, suurendada sotsiaalset kaasatust, tugevdada ennetustööd ja eneseabi ning korraldada psüühika- ja käitumishäiretega inimestele ning nende hooldajatele abi, adekvaatset ravi ja taastumist. Maailma Terviseorganisatsioon leiab, et selline poliitika peaks olema igal riigil. 2002. a lõpus valmis Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument, kuid tegevuskavani siiski ei jõutud. Eestis asutati 2012. a Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ning sotsiaalministeeriumi toetusel Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK), mis töötaski välja vaimse tervise strateegia aastateks 2016–2025.

Strateegia koostamisel on järgitud vastava

poliitika kujundamist Euroopas, milles on osalenud nii Maailma Terviseorganisatsioon kui ka Euroopa Komisjon. Jaanuaris 2005 võttis Maailma Terviseorganisatsioon vastu vaimse tervise deklaratsiooni ja tegevuskava. Euroopa Komisjon koostas vaimse tervise roheline raamatu (*Green Paper* 2005), mida aastatel 2005–2006 arutasid ka liikmesriigid. Euroopa Komisjon algatusel viidi 2013–2016 ellu ühistevgevuste projekt „*Joint Action on Mental Health and Wellbeing*”, mis töötas liikmesriikide jaoks välja soovitusel. Maailma Terviseorganisatsioon võttis 2013. aastal vastu „Vaimse tervise tegevuskava 2013–2020”.

Strateegia koostamise protsessi Eestis võib jagada viieks etapiks: 1) sisendi kogumine maakondlikel teabepäevadel; 2) strateegia kirjutamine laste ja noorte, tööeliste ning eakate valdkonna töögruppides; 3) koostöö ministerriumite ja erialaorganisatsioonide esindajatega; 4) koostöö vaimse tervise ekspertidega; 5) koostöö VATEKi liikmetega igakuistel koosolekutel.

Sihtrühm ja eesmärk

Strateegia sihtgrupiks on nii vaimse tervise valdkonnas töötavad kui ka sellega kaudsemalt seotud poliitikud ja spetsialistid ministerriumites, omavalitsustes, haridus- ja tervishoiuasutustes ning organisatsioonides, äri sektoris jm, kes oma otsuste ja tegevusega mõjutavad elanikkonna vaimset tervist ja heaolu.

Muidugi on strateegia mõeldud ka kõigile sotsiaaltöötajatele, perearstidele, haridustöötajatele jm spetsialistidele, kes saavad kaasa aidata inimeste vaimse tervise edendamisele. Sotsiaaltöötajad puutuvad oma töös kokku paljude inimestega ja saavad oma töösse integreerida vaimse tervise edendamise temaatika (sh füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomine, teadlikkuse kujundamine, eluviis soovitusel andmine). Vaimse tervise strateegia toob välja vastavad tegevussoovitusel nii

indiviidi kui ka kogukonna tasandil.

Vaimse tervise strateegia üldeesmärk on: „*Eesti elanikud on hea vaimse tervisega ja annavad enda heaolule järjest kõrgemaid hinnanguid, psüühikahäireid märgatakse varakult ja inimesed saavad vajalikku abi. Vaimse tervise edendamine on ühiskonnas prioriteet ja sellega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.*”

Vaimse tervise strateegia üldeesmärgi täitmiseks on sõnastatud kolm alaeesmärki:

- 1. Vaimse tervise edendamine:** inimeste hoiakud, ümbritsev keskkond ja elutingimused on kujundatud sellisel, et need toetavad inimeste tervislikku eluviisi ja loovad eelduse heaks vaimseks terviseks.

- 2. Psüühika- ja käitumishäirete ennetamine:** inimesed oskavad võimalikult varakult ära tunda häirete tekkimise, nad julgevad abi küsida ja neile on tagatud professionaalne õigeaegne abi tõsisemate häirete ennetamiseks.

- 3. Psüühika- ja käitumishäirete ravi ja taastumine:** inimestele on kättesaadav parim võimalik ravi ja seda toetavad teenused nii, et inimesed saavad enda eluga iseseisvalt hakkama.

Strateegia ideoloogiline ülesehitus lähtub Maailma Terviseorganisatsiooni käsitlusest: vaimne tervis on oluline eeltingimus inimese üldise tervise ja heaolu saavutamisel ning mõjutab otseselt inimeste eluga toimetulekut ja hakkamasaamist.

Strateegia põhisõnumid

Vaimne tervis ning psüühika- ja käitumishäired kujunevad bioloogiliste, sotsiaalsete, psühholoogiliste, keskkondlike ja majanduslike tegurite koosmõjus. Seega tuleb inimeste vajadusi hinnata võimalikult mitmekülgselt, seostades eri valdkondi. Tihti paigutatakse vaimne tervis pelgalt tervishoiuvaldkonda, kuid ka sotsiaalvaldkonna teenused ja abi aitavad edendada vaimset tervist ning ennetada häireid.

Vaimse tervise paranemise nimel peavad koostööd tegema ja vastutuse võtma nii inimesed ise, neid ümbritsev kogukond ning tervise-, sotsiaal-, haridus-, sise-, kaitse-, justiits- ja töövaldkonna institutsioonid. Paljud inimesed vajavad samal ajal nii tervishoiu-, hoolekande- kui ka õiguskaitsevaldkonna tähelepanu ja teenuseid. Seejuures tuleb vältida kattuvaid tegevusi, tagada teenuste järjepidevus, sõnastada selged eesmärgid ja vastutused protsessi jälgimisel.

Vaimne tervis on tähtis kogu inimese elukaare vältel – sünnist kuni kõrge vanuseni. Abi ja toetus peavad alati olema kooskõlas eakohaste vajadustega ning tagama igas vanuses inimestele inimväärse kohtlemise. Vaimsete häirete ennetamine ja varajane sekkumine on tulemuslikud ka vanemas eas. Senisest rohkem tuleb Eestis keskenduda eakate inimeste elukvaliteedi edendamisele ja selle taseme säilitamisele.

Kõigil inimestel on õigus heaolule ja vaimse tervise teenustele sõltumata nende rahvusest, vanusest, soost, elukohast ning sotsiaalmajanduslikust staatusest. Keelatud on igasugune diskrimineerimine. Diskrimineerimise keelustamise ja võrdse kohtlemise põhimõtete juurutamine ühiskonnas eeldab sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi ning tähelepanu pööramist ka puuduses elavatele ja marginaliseeritud elanikkonna-gruppidele. See eeldab kogukonna suuremat

hoolivust ning omavalitsuste, äriettevõtete, tervishoiu- ja haridusasutuste jt ühiskondlike institutsioonide paremat koostööd.

Psüühika- ja käitumishäiretega inimeste, nende abistajate ja perekondade õigusi ning vajadusi tuleb austada ja kaitsta. Eakate, krooniliste haigete, puude või mõne muu pikaajalise tervise puudujäägiga inimeste toimetulekul on olulise tähtsusega nende lähivõrgustik ja perekond. Pereliikmetele langev suur hoolduskoormus mõjutab nende elukvaliteeti ning seab ohtu ka nende vaimse tervise.

Kuidas strateegia eesmäärke saavutada?

Eesti vajab eraldi poliitikat, mis esitaks soovitud vaimse tervise edendamise, diskrimineeriva häbimärgistamise vähendamise, sotsiaalse kaasatuse suurendamise, ennetava tegevuse ja eneseabi tugevdamise ning psüühika- ja käitumishäiretega inimeste ja nende hooldajate abistamise ning adekvaatse ravi ja taastumise korraldamiseks. Eri valdkondade tegevusi ja sekkumisi tuleb strateegiliselt planeerida, määrata valdkondade vastutus ning hinnata sekkumiste tulemuslikkust.

Strateegiaga saate tutvuda VATEKi kodulehel www.vatek.ee. Strateegia koostati sotsiaalministeeriumi ja EMP toetusel. **S**

Viidatud allikad

- Eesti vaimse tervise poliitika alusdokument* (2002). <http://praxis.ee/wpcontent/uploads/2014/03/2002-Eesti-vaimse-tervise-poliitika.pdf> (17.01.2017).
- Green Paper* (2005). Improving the mental health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union. European Communities. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf (17.01.2017).
- Joint Action on Mental Health and Wellbeing* (s. a.). www.mentalhealthandwellbeing.eu/ (17.01.2017).
- Mental health action plan 2013–2020* (2013). Geneva: World Health Organization. www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/ (17.01.2017).
- Mental Health Declaration for Europe: Facing the Challenges, Building Solutions* (2005). World Health Organization. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/88595/E85445.pdf (17.01.2017).
- Mental health: facing the challenges, building solutions* (2005). Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96452/E87301.pdf (17.01.2017).
- Statistika andmebaas* (2016).